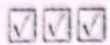


92★★★★



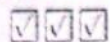
潜伏期間は 3~4 週間である。

93★★★★



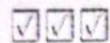
肥満、高齢、喫煙、糖尿病は重症化のリスク因子である。

94★★★★



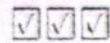
発熱・気道症状に加え、**嗅覚・味覚**障害が特徴的とされる。

95★★★★



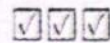
血液検査では白血球や D-dimer、CRP、フェリチン、インターロイキン 6 が高値を示す。

96★★★★



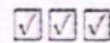
無症状の場合でも胸部 CT で肺炎像がみられることがある。

97★★★★



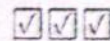
典型的な CT 所見としては、両側・末梢側優位のすりガラス影と浸潤影を呈する。

98★★★★



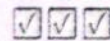
抗ウイルス薬の効果は、変異株の種類によって変化する。

99★★★★



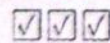
中等症~重症の患者では抗凝固薬を使用する。

100★★★★



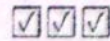
全例でデキサメサゾンによる副腎皮質ステロイドの全身投与が推奨される。

101★★★★



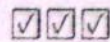
急速に重症化しつつある症例では、副腎皮質ステロイドに加えてトシリズマブやバリシチニブの使用を考慮する。

102★★★★



抗体カクテル療法は発症 14 日以内の重症患者のみに有効である。

103★★★★



PCR 検査が陽性であれば、感染性を有すると判断する。